ИНСТРУМЕНТ 3 / 5

Визуален детектор: клас II срещу клас III

Дентален, скелетен или функционален? Разграничете ги за две минути – от моларите и кучешките зъби до цефалометрията, със сравнения една до друга.

РАЗДЕЛ 1

Клас II: дентален или скелетен?

Едно и също моларно съотношение клас II има различни причини. Изборът на лечение зависи от причината.

> *Моларното съотношение започва диагнозата; ANB, Wits и профилът я поставят. Компенсацията на резците показва дали overjet прикрива реалната разлика.*

ИНТРАОРАЛНО

ДЕНТАЛЕН КЛАС II

- Моларен и кучешки клас II; най-често мезиално придвижване на горните зъби (ранна загуба на млечни молари, загуба на място)
- Увеличеният overjet идва от проклинация на горните резци или от диастема
- Чест е едностранен клас II; заедно с отклонение на средната линия

СКЕЛЕТЕН КЛАС II

- Моларен и кучешки клас II, сходно от двете страни
- Голям overjet; при подклас 2 горните централни резци са ретроинклинирани, overjet е малък, дълбоката захапка е изразена
- Долните резци са проинклинирани (компенсация)

ЦЕФАЛОМЕТРИЯ

ДЕНТАЛЕН КЛАС II

- ANB в границите на нормата (~2° ± 2)
- Wits близо до нормата
- SNA около ~82°, SNB около ~80°
- U1-SN може да е увеличен; IMPA близо до нормата

СКЕЛЕТЕН КЛАС II

- ANB над 4°
- Wits увеличен в положителна посока
- Нисък SNB (мандибуларна ретрогнатия, най-често) и/или висок SNA (максиларен прогнатизъм)
- Увеличен IMPA: долните резци се опитват да компенсират разликата

ЛИЦЕ

ДЕНТАЛЕН КЛАС II

- Профилът е прав или леко конвексен
- Брадичката е в нормална позиция; устните се затварят свободно или само горната устна е изтласкана напред

СКЕЛЕТЕН КЛАС II

- Конвексен профил, ретропозиция на брадичката, къса линия шия–брадичка
- Напрежение на m. mentalis при затваряне на устните; долната устна може да застава зад горните резци

Тест с конструктивна захапка

Помолете пациента да изведе мандибулата напред до кучешко съотношение клас I и погледнете профила. Ако профилът видимо се подобрява, проблемът е предимно в мандибулата; при пациент в растеж той е кандидат за функционален апарат (Twin Block, Herbst). Ако профилът се влошава (брадичката излиза напред), проблемът е в максилата или е дентален.

РАЗДЕЛ 2

Клас III: дентален, скелетен или псевдо?

При клас III има трета възможност: псевдо клас III от функционално отклонение. Първо го изключете.

ИНТРАОРАЛНО

ДЕНТАЛЕН КЛАС III

- Моларен клас III или клас I; предна кръстосана захапка при един или няколко зъба
- Горните резци са ретроинклинирани, долните – проинклинирани (самата причина)
- Няма костно несъответствие между дъгите

СКЕЛЕТЕН КЛАС III

- Моларен и кучешки клас III, сходно от двете страни
- Отрицателен overjet или край в край; често задна кръстосана захапка
- Горните резци са проинклинирани, долните – ретроинклинирани (компенсация)

ЦЕФАЛОМЕТРИЯ

ДЕНТАЛЕН КЛАС III

- ANB в границите на нормата
- Wits близо до нормата
- SNA и SNB близо до нормата
- Инклинацията на резците е източникът на проблема

СКЕЛЕТЕН КЛАС III

- ANB 0° или отрицателен
- Wits увеличен в отрицателна посока
- Нисък SNA (максиларна ретрузия) и/или висок SNB (мандибуларен прогнатизъм)
- Намален IMPA: долните резци са наклонени назад

ЛИЦЕ

ДЕНТАЛЕН КЛАС III

- Прав профил; плътна средна трета на лицето
- Балансирана брадичка

СКЕЛЕТЕН КЛАС III

- Конкавен профил; средната трета е плоска или хлътнала, изразена брадичка
- Долната устна е пред горната; честа фамилна анамнеза

Разграничаване на псевдо клас III: тест с централна релация

ПСЕВДО КЛАС III (ФУНКЦИОНАЛЕН)	ИСТИНСКИ СКЕЛЕТЕН КЛАС III
• В централна релация резците могат да застанат край в край • При затваряне – ранен преден контакт, след което мандибулата се плъзга напред • В централна релация моларното съотношение е близо до клас I • В централна релация профилът се изправя • Горните резци са ретроинклинирани, долните – нормални или леко проинклинирани	• Отрицателният overjet остава и в централна релация • Няма или има минимално отклонение; централната релация и навиковата оклузия съвпадат • Моларен клас III и в двете позиции • Конкавен профил и в двете позиции • Изразена дентална компенсация

1. **Отпуснете пациента** — изправено седнал, главата изправена; помолете го да отпусне дъвкателните мускули.
2. **Водете мандибулата** — водете леко назад и нагоре от брадичката; без натиск.
3. **Наблюдавайте първия контакт** — контактът при резците ли е? Застават ли край в край?
4. **Измерете отклонението** — отбележете колко напред се плъзга мандибулата от първия контакт до пълното затваряне.
5. **Сравнете профила в двете позиции** — страничен профил в централна релация и в навикова оклузия.

Честа грешка

Да направите цефалограмата в навикова оклузия и да заключите скелетен клас III. При функционално отклонение мандибулата изглежда по-напред и ANB излиза по-лош, отколкото е. Запишете отклонението клинично и тълкувайте според него.

При пациент в растеж

При ранен клас III с максиларна ретрузия лицевата маска, при нужда заедно с RME, има смисъл, ако започне навреме. При мандибуларен прогнатизъм е нужно проследяване до края на растежа и обсъждане на хирургичния вариант.

РАЗДЕЛ 3

Обобщаваща таблица: отпечатайте и закачете

Впишете стойността на пациента в последната колона. Започнете от колоната, в която са повечето съвпадения.

КРИТЕРИЙ	ДЕНТАЛЕН II	СКЕЛЕТЕН II	ДЕНТАЛЕН III	СКЕЛЕТЕН III	ПСЕВДО III	ПАЦИЕНТ
Молари / кучешки зъби	Клас II, често едностранно	Клас II, двустранно	Клас I–III	Клас III, двустранно	В ЦР близо до клас I	
Overjet	Увеличен, от резците	Увеличен (малък при подклас 2)	Предна кръстосана, няколко зъба	Отрицателен / край в край	В ЦР край в край	
ANB	~2° ± 2	> 4°	~2° ± 2	≤ 0°	В ЦР ~нормален	
Wits	Близо до нормата	Увеличен положителен	Близо до нормата	Увеличен отрицателен	В ЦР ~нормален	
SNA / SNB	~82° / ~80°	Нисък SNB и/ или висок SNA	Близо до нормата	Нисък SNA и/ или висок SNB	Близо до нормата	
Профил	Прав–леко конвексен	Конвексен, брадичка назад	Прав	Конкавен	В ЦР се изправя	
Горен резец	Проклинация	Подкл. 1: протрудирани · подкл. 2: ретроинклинирани	Ретроинклинирани	Проклинация (компенсация)	Ретроинклинирани	
Долен резец (IMPA)	~90°	Увеличен (компенсация)	Проклинация	Намален (компенсация)	Нормален / леко увеличен	
Тест при затваряне	Извеждането напред влошава профила	Извеждането напред подобрява профила	Няма отклонение	Няма отклонение	В ЦР край в край	

КРИТЕРИЙ	ДЕНТАЛЕН II	СКЕЛЕТЕН II	ДЕНТАЛЕН III	СКЕЛЕТЕН III	ПСЕВДО III	ПАЦИЕНТ
Първа мисъл	Дентална механика, управление на мястото	При растеж – функционален апарат; иначе камуфлаж или хирургия	Корекция на инклинацията на резците	При растеж – лицева маска; иначе камуфлаж или хирургия	Ранна корекция на предна кръстосана захапка	

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

Ако сте поставили диагнозата, отворете **Модул 05 Сагитални проблеми: клас II и клас III** . Ако пациентът е в растеж, вижте сходния случай в **Ръководство 5 · Клиничен атлас по дентофациална ортопедия** , след това запишете плана в **Инструмент 4 · Клиничен планер в 4 етапа** .